

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN <i>DISTOSIA</i> BAHU		
	No. Dokumen 571.26/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Tindakan yang dilakukan pada pertolongan persalinan dengan kegagalan bahu untuk melipat ke dalam panggul (misalnya pada bayi makrosomia) terutama disebabkan oleh deformasi panggul karena fase aktif dan kala II yang pendek pada multi para sehingga penurunan kepala yang terlalu cepat menyebabkan melpat pada saat melalui jalan lahir atau kepala tidak melalui pintu tengah panggul setelah mengalami perpanjangan kala II sebelum bahu berhasil melipat ke dalam panggul.		
Tujuan	Bayi selamat dan mencegah terjadinya trauma persalinan.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan		
Prosedur	1. Lakukan komunikasi terapeutik kepada ibu Jelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya 2. Buatlah episotomi yang cukup luas untuk mengurangi obstruksi jaringan lunak yang memberi ruangan yang cukup untuk tindakan. 3. Dengan posisi pasien berbaring terlentang, mintalah pasien menekuk tungkainya dan mendekatkan lututnya ke arah dadanya. Mintalah bantuan 2 orang asisten untuk menekan fleksi kedua lutut pasien ke arah dada. 4. Dengan memakai sarung tangan DTT: a) Lakukan tarikan yang kuat dan terus menerus ke arah bawah pada kepala bayi untuk menggerakkan bahu depan di bawah symphysis pubis. b) Mintalah seorang asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke arah bawah pada daerah supra pubis untuk membantu persalinan bahu. 5. Jika bahu masih belum dapat dilahirkan: a) Pakailah sarung tangan DTT dan masukkan tangan ke dalam vagina. b) Lakukan penekanan pada bahu anterior sesuai arah sternum bayi untuk memutar dan mengecilkan diameter bayi.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN <i>DISTOSIA</i> BAHU		
	No. Dokumen 571.26/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	c) Jika diperlukan, lakukan penekanan pada bahu belakang berkebalikan dengan arah sternum.		
Prosedur	Jika bahu masih belum dapat dilahirkan setelah dilakukan tindakan di atas: - Masukkan tangan ke dalam vagina. - Raih humerus dan lengan belakang, dan dengan menjaga lengan tetap fleksi pada pasien, gerakkan lengan ke arah dada. Tindakan ini akan memberikan ruangan untuk bahu depan agar dapat bergerak di bawah symphysis pubis. 6. Jika semua tindakan di atas tetap tidak dapat melahirkan bahu, pilihan lain adalah: - Patahkan klavikula untuk mengurangi lebar bahu dan bebaskan bahu depan. - Lakukan tarikan dengan mengikat ketiak untuk mengeluarkan lengan belakang. 7. Dokumentasi - Respon pasien pada saat di lakukan tindakan - Nilai kondisi pasien (vital sign, keluhan subyektif, dan nilai kondisi jalan lahir.		
Unit Terkait	- IGD - Ruang Kandungan & Kebidanan		